

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	小兒生理監視器警告值上下限設定與回應處理標準 The SOP of Pediatrics Physiological Monitoring and Its Corresponding Upper/Lower Limits Setting and Warning Alarm Reporting				
編號	A31000-Q02-W-O12	制定者	NI 邱曉彤	公布日期	106 年 05 月 04 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 1.5 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

提供正確、安全且有效的監視器警告功能並能即時處理，以維護病人安全。

二、範圍

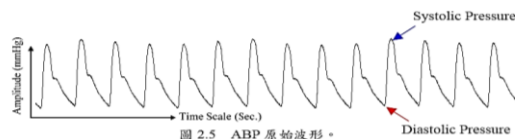
護理部兒科單位。

三、說明

- (一) 警示開關保持“開(On)”狀態，不可將個別參數如：心跳(HR)、周邊血氧飽和度(SpO2)、血壓(BP)等警示關閉(Alarm off)，除非有合適理由與記錄。
- (二) 生理監視器 BSM-6701K 當開機時，儀器會進行紅黃綠燈，燈號自我測試，與一聲試鳴警報，同仁須確定其警報功能正常，若測試不過將無法進入監視畫面，請進行故障排除，以確保病人之安全。
- (三) 警報設定須由主護負責設定，其他人員不得更改其警報設定。
- (四) 警報上下限設定時機：在接班時需參考上一班病人的生命徵象作為設定依據，若病人生命徵象改變，給予處理後，若需要則調整警報上下限，需告知醫療團隊人員，列入交班，並有紀錄。
- (五) 周邊血氧飽和度(SpO2)警告上、下限設定適當值：最低為 88%，若低於 88%者下限設定時須更密切注意。若必須調整設定範圍，應有理由與記錄。
- (六) ABP 的波峰振幅大小為收縮壓，而波谷振幅大小為舒張壓（圖一），影響動脈壓波形的因素有姿勢折到導管、加壓袋壓力不足、動脈導管血塊阻塞，應加以注意。若動脈導管顯示的波形不易正常判讀時，應以非侵入性血壓監視器(NBP)替

主題名稱	小兒生理監視器警告值上下限設定與回應處理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O12	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	2/6

代。



圖一、ABP 波形

(七) 心跳、呼吸、血壓警告上下限設定適當值(如表一)，若必須調整設定範圍，應有理由與記錄。

項目 年齡	心跳次數 (次/分)	呼吸次數 (次/分)	血壓 mmHg (收縮壓/舒張壓)
早產兒	120-170	40-70	75-55/45-35
0-3 月	100-150	35-55	85-65/55-45
3-6 月	90-120	30-45	90-70/65-50
6-12 月	80-120	25-40	100-80/65-55
1-3 歲	70-110	20-30	105-90/70-55
3-6 歲	65-110	20-25	110-95/75-60
6-12 歲	60-95	14-22	120-100/75-60
12 歲以上	55-85	12-18	135-110/85-65

(八) 將正確數據記錄於生命徵象紀錄單，若有異常變化應於護理紀錄呈現，測量時間設定依據各單位常規設定。

(九) 病人生理監視器紅色警告時(Alarm)須優先處理，其包括 VT、VF 和 Asystol 護理人員能在 10 秒內回應，黃色警告則須在 20 秒內回應，並依警告狀況給予適切處理，處理如下

- 心跳太快或太慢時，應先排除心電圖波型是否受到干擾，並觀察波型變化。
無特殊變化則觀察是否有任何不適，處理引起心跳速率變化之原因；若心電圖波型有變化則需判讀為何種波型，請醫師立即做處理(如：給藥、電擊)。
- 血壓太高或太低時，排除壓脈帶鬆脫或動脈導管管路折到等因素，並觀察是否有無不適情形給予處理。
- 呼吸速率太快或太慢時，先排除波型干擾，觀察是否呼吸不順、費力或呼吸中止情形給予處理。

主題名稱	小兒生理監視器警告值上下限設定與回應處理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O12	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	3/6

4. 周邊血氧飽和度太低時，排除感應不良，觀察是否有缺氧（供應氧氣管路脫落）或疾病因素造成給予處理。

（十）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）李瑜弘(2024)．血液動力監測．於蔡秀鸞總校閱，重症護理學（四版，6-18）．台灣：永大。
- （二）林依潔(2022)．醫療儀器警報管理在內科加護病房急重症生理監視器的應用．未發表碩士論文，台中：中國醫藥大學碩士。
- （三）洪郁涵(2021)．探討加護病房護理人員對於生命監測系統輸入模式之相關性．未發表碩士論文，台中：中山醫藥大學。
- （四）賴佩霞、蔡宛容、李若嘉、馮葶憶(2020)．提升加護病房護理人員執行心肺容積監視器照護正確性之專案．志為護理，19(4)，67-79。
- （五）Joint Comission Internal (2021). Joint Comission Internal Accreditation Standards for Hospitals. Joint Comission Resources. <http://www.jcrinc.com>
- （六）Nelson Texbook of Pediatrics. (2021) 18th ed.Saunders, 70-74.

七、附件

主題名稱	小兒生理監視器警告值上下限設定與回應處理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O12	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	4/6

(略)

主題名稱	小兒生理監視器警告值上下限設定與回應處理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O12	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
106.05.04	1.0	新制定。	106 年 05 月 04 日護理部照護標準委員會通過；106 年 05 月 04 日公布。
106.12.04	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
109.01.21	1.1	第三項第十日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 12 月 19 日照護標準組會議通過；109 年 01 月 08 日護理長會議通過；109 年 01 月 21 日督導會議通過公布。
109.06.16	1.2	依 109/4/27 加護病房管理委員會決議：第三項第四目新增說明內容：需告知醫療團隊人員，列入交班。	109 年 06 月 04 日照護標準組會議通過；109 年 06 月 10 日護理長會議通過；109 年 06 月 16 日督導會議通過公布。
110.12.02	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.02.07	1.3	第六項參考資料更新。	111 年 12 月 08 日照護標準組會議通過；111 年 12 月 14 日護理長會議通過；112 年 02 月 07 日督導會議通過公布。
112.12.07	1.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	小兒生理監視器警告值上下限設定與回應處理標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-O12	版本	第 1.5 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
113.04.16	1.4	第三項第九目刪除文字說明：生理監視器 BSM-6701K 及 HP M1205A。	113 年 04 月 11 日照護標準組會議通過；113 年 04 月 16 日督導會議通過公布。
113.12.05	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.01.06	1.5	1.第三項第九目第 4 點字詞修訂。 2.第六項參考資料更新。	114 年 12 月 04 日照護標準組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。